

総論

抗がん剤の分類と作用機序:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ☐ 経口抗がん剤の服用時点・服用日・残薬の管理
- ☐ 他院処方・市販薬・サプリを含む相互作用の確認
- ☐ 服用期間中の電話フォローと早期受診の勧奨
- ☐ 副作用をGradeで記録し、トレーシングレポートで病院へ
- ☐ 家庭での曝露対策・長期服用のアドヒアランス支援

病院薬剤師

- ☐ レジメン監査・投与量計算・前投薬の確認
- ☐ 抗がん剤の調製と曝露対策
- ☐ 外来化学療法室での副作用説明・導入時の指導
- ☐ 副作用発現時の院内連携(各診療科)
- ☐ お薬手帳へのレジメン情報の記載・薬局への情報提供

病院と共有する情報

レジメン名・投与日

検査値

副作用のGrade

服用状況・残薬

2 経口抗がん剤の服用時点と注意点

薬剤	服用時点・食事の影響	主な注意点
S-1	1日2回 朝夕食後	4週服用・2週休薬などの休薬期間、腎機能に応じた用量、他のフッ化ピリミジン系と併用禁忌
カベシタビン	1日2回 朝夕食後30分以内	手足症候群、ワルファリン併用時のINR上昇
エルロチニブ	1日1回 空腹時(食事の1時間以上前または食後2時間以降)	皮疹・下痢、胃酸分泌抑制薬で吸収低下、喫煙で血中濃度低下
ニロチニブ	1日2回 空腹時(同上)、約12時間ごと	QT延長、グレープフルーツ、胃酸分泌抑制薬
アビラテロン	1日1回 空腹時(食事の1時間前～食後2時間は避ける)	プレドニゾロンの併用、肝機能・低K血症・高血圧
レゴラフェニブ	1日1回 食後(高脂肪食の後は避ける)	手足症候群、投与初期の肝機能・血圧
タモキシフェン	1日1回	CYP2D6阻害薬(パロキセチン等)、血栓症・子宮体がん

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌	S-1 DPD阻害(ギメラシル)	処方薬 他のフッ化ピリミジン系(カベシタビン・5-FU等)	5-FU濃度↑ → 重篤な骨髄抑制・下痢	切り替え時は7日以上空ける
注意	経口分子標的薬(イマチニブ等) CYP3A4阻害・誘導	処方薬 クラリスロマイシン・アゾール系・リファンピシン	副作用↑・効果↓	他院の抗菌薬・抗真菌薬・抗結核薬を確認
注意	エルロチニブ・タサチニブ等 胃内pH上昇で吸収低下	処方薬 市販薬 PPI・H2ブロッカー(市販の胃薬も)	血中濃度↓ → 効果減弱	市販の胃薬も確認、服用時間を調整
注意	経口分子標的薬 CYP3A4阻害・誘導	サプリ・食品 グレープフルーツ・セイヨウオトギリソウ	副作用↑・効果↓	食品・サプリの摂取を聴取
注意	タモキシフェン CYP2D6阻害(活性化↓)	処方薬 パロキセチン等の強いCYP2D6阻害薬	効果減弱のおそれ	他院の抗うつ薬の処方を確認
確認	ICI 免疫反応の増強	既往・疾患 自己免疫疾患・間質性肺疾患の既往	irAE・既往の増悪	既往歴と他院での治療状況を確認

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前

「がん細胞の増殖のスイッチを止める薬です。毎日決まった時間に飲み続けることが大切です」

確認:お薬手帳でレジメン・分類、他院処方・市販薬・サプリ

△ 経口薬は粉砕・脱カプセルしない(曝露対策)

開始～2週

「熱や下痢、皮膚の変化など、今までと違う症状があれば、次の受診を待たずに教えてください」

確認:電話フォローで分類ごとの初期症状(発熱・皮疹・下痢)を確認

△ 発熱・水様便が続く時は至急連絡

1～3か月

「だるさや口の渇き、動悸が続く時も連絡を。免疫の薬は時間がたってから症状が出る場合があります」

確認:ICIのirAE、家庭血圧・尿蛋白(血管新生阻害薬)

△ 息切れ・空咳・発熱はILDを疑い早めに受診

長期服用中

「関節の痛みやほてりは対処法があります。自己判断でやめずに相談してください」

確認:ホルモン剤・分子標的薬の継続状況と残薬、骨密度検査

△ 自己中断・飲み忘れはトレーシングレポートで共有